SGK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

ECZANE DENETİM REHBERİ

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

2009

HİZMETE ÖZEL

ÖNSÖZ

Sosyal güvenlik reformu kapsamında sağlanan uygulama birlikteliğiyle sağlık hizmetlerinin temininde önemli bir iyileştirme hayata geçirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığımız tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğiyle, sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere Kurum ile sözleşmesi bulunan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilme imkanı getirilmiş, hastaların ilaçlarını doğrudan sözleşmeli eczanelerden temin etmeleri sağlanmıştır.

Bu noktada sağlık hizmetine erişimin kolaylaşması, hizmetin nitelik ve niceliğinin artması nedeniyle sağlık giderlerinde artış olmuştur. Sağlık giderlerindeki bu artış tabiidir. Ancak sağlık giderlerinin çeşitli usulsüzlüklerle arttırılması ile de mücadele edilmektedir.

Sağlık suiistimalleri ile mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin sağlık suiistimalleri ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek adına başta Kurumumuz ile sözleşme imzalayan eczanelerde yapılacak ilaç temini incelemelerine ilişkin usul ve esaslara yer verilen Eczane Denetim Rehberinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapma işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız güncel, etkin, caydırıcı, ilgilileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyi de amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Sağlık suiistimalleri ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir.

Sağlık suiistimalleriyle mücadelede etkin ve caydırıcı denetim sistemi kurma hedefine ulaşacak olan Başkanlığımız, Eczane Denetim Rehberini; Kurumumuz ile sözleşme imzalayan eczanelerden ilaç temin edilmesi incelemelerinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere sağlık suiistimalleriyle mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

Sunuş..... ii
Önsöz iii
İçindekiler..... iv

1. Amaç 1
2. Kapsam..... 1
3. Dayanak..... 1
4. Eczane Denetimlerinde Yararlanılacak Mevzuat Hükümleri..... 1

4.1. 5510 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Hükümleri..... 1
4.2. Diğer Mevzuat Hükümleri..... 1

5. Eczanelerle İlgili Genel Bilgiler 4
6. Görev Onayının Değerlendirilmesi..... 5
7. Eczane Nezdinde İnceleme Yapılması..... 7
8. Sağlık Kurumlarında İnceleme Yapılması 9
9. Bilirkişi Uygulaması..... 10
10. İfade Alınması..... 10
11. Yatan Hastalara Ait Reçeteler..... 12
12. Sahte Reçeteler..... 14
13. Sahte Raporlar..... 15
14. Sahte Kupürler..... 15
15. Tahrifatlı Reçeteler..... 16
16. Yönlendirme Konuları..... 17
17. Raporlama İşlemleri..... 17

EK: 1 (01.02.2009´dan geçerli Protokol´ün 5 ve 6´ncı maddeleri).. 19
EK : 2 Eczacı Odaları Telefon Bilgileri..... 31

1. Amaç

Bu rehberin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan eczanelerde yapılacak, ilaç temini incelemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir

2. Kapsam

Bu rehber, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan eczanelerde yapılacak ilaç temini incelemelerini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Eczane Denetimlerinde Yararlanılacak Mevzuat Hükümleri

4.1. 5510 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Hükümleri

4.1.1. 5510 sayılı yasanın 63'üncü maddesinde kişilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tedavilerin karşılanacağı gösterilerek (m:63/1-b), ilgili teşhis ve tedavi için gerekli olabilecek ilaçların sağlanacağı belirtilmiştir (m:63/1-f).

4.1.2. Sağlanacak ilaç miktarı ve kullanım süresini, ödeme usul ve esaslarını Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir (5510 Sayılı Kanun m:63/2nci fıkra).

4.1.3. Kurum, ilaç hizmetlerini, sağlık hizmeti sunucuları (eczane ve yataklı tedavi kurumları) ile sözleşme yaparak sağlar. (5510 Sayılı Kanun m:73/1'inci fıkra).

4.1.4. Kurumca finansmanı sağlanacak beşeri ilaçlar, Kurum, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Ödeme Komisyonu marifetiyle tespit edilir. Kurumca sağlanacak beşeri ilaçların listesi Kurumca çıkarılacak yönerge ile belirlenir. Acil haller dışında ayakta tedavilerde gerekli görülen ilaçların sözleşmeli eczanelerden temin edilmesi zorunludur (Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği, m:21).

4.1.5. Kurumca sağlanacak sağlık hizmetlerinin neler olduğu, ödeme esas ve usulleri Sağlık Uygulama Tebliğinde gösterilir (GSSİ Yönetmeliği, m:62). 29.09.2008 tarihli ve 27012 sayılı Resmi gazetede 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği yayınlanmıştır (Daha önceki tarihlerle ilgili inceleme söz konusuysa 2007 yılı SUT veya 15.6.2007 öncesi için de ilgili yılların sağlıkla ilgili Bütçe Uygulama Talimatlarına bakılması gerekir).

4.1.6. 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin (2008)) 12'nci maddesinde reçete ve sağlık raporlarının düzenlenmesi ile ilgili esaslar, 14'üncü maddesinde indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması, 15'inci maddesinde eczanelerden ilaç temini, 17'inci maddesinde hemofili ve diğer kan ürünlerinin reçetelendirilmesi, 20.3.10 maddesinde enjektör bedellerinin ödenmesi, 21'inci maddesinde sağlık raporlarının düzenlenmesi, 25.2.2 maddesinde eczane faturalarının düzenlenmesi ile ilgili hükümler yer almıştır.

4.1.7. İlaçlarla ilgili bazı düzenlemeler SUT eki listelerde gösterilmiştir:Hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi ek:2'de; sistemik antimikrobik ve diğer ilaçların reçeteleme kuralları ek:2/A'da; sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar ek:2/B'de; ayakta tedavide sağlık raporu (uzman hekim

raporu/sağlık kurulu raporu) ile verilebilecek ilaçlar listesi ek:2/C'de; bedeli ödenecek ilaçlar listesi ek:2/D'de belirlenmiştir.

4.1.8. Kurumumuzla Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında imzalanan ve 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 19.01.2009 tarihli "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ile reçetede bulunması gereken özellikler, reçete iadesi, indirim oranı, katılım payı tahsili, fatura düzenlenmesi, fatura teslimi, fatura incelemesi ve ödemesi, sözleşmenin feshi ve cezai şartlarla ilgili ayrıntılı düzenlemeler yer almıştır. Protokol'ün, **Cezai Şart Tahsili**, **Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar** ile ilgili maddeleri, eczane inceleme veya soruşturmalarında sık başvurulabilecek kaynak olduğundan Rehber sonuna konmuştur (EK:1).

4.1.9. Protokol süresi 3 yıldır (protokol, m:9) ve her yıl Şubat ayında eczane sözleşmeleri yenilenir (protokol, m:7.1). Kurum, protokol hükümlerini kabul eden ve başvuru formunu getiren her eczane ile (fesih süresine tabi olanlar ve muvazaalı açılanlar hariç) sözleşme yapar (protokol,m:7.1).

4.1.10. Fatura ve Benzeri Belgelerin İncelenmesi başlıklı ek madde ile sağlık hizmeti sunucularının (eczanelerin) Kuruma gönderdikleri faturaların, %5-10 oranında örnekleme metoduyla incelenmesi kabul edilmiştir(8.3.1997 tarihli ve 5597 sayılı yasanın 4'üncü maddesi ile 5502 yasaya eklenen ek birinci madde). Örnekleme yöntemiyle ilgili ayrıntılar ve uygulamalar Ödeme Genelgesinde belirlenmektedir(2007/46 s.g. *ve bu genelgeyi kaldıran 12.03.2009 gün ve 2009/44 s.g.).*

4.1.11. Mevcut uygulamada A grubu reçeteler (yatan hasta, günübirlik tedavi reçeteleri, raporlu reçeteler) % 10; B grubu reçeteler (ayakta tedavi görenlerin reçeteleri....) %5 örnekleme yöntemi ile ödenmektedir. C grubu reçeteler (kan ürünü ve hemofili ilacı içeren

reçeteler, SUT'un 25.2.2 numaralı maddesinin a, b, c, f bentlerinde sayılan reçeteler) ise örneklemeye dahil edilmeden incelenmekte ve ödenmektedir.

4.2. Diğer Mevzuat Hükümleri

4.2.1. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 18.12.1953 tarihli ve 6197 Sayılı Kanun'a göre vefat eden, hacredilen, devamlı malüliyete uğrayan, askerlik hizmeti için silah altına alınan veya milletvekili veya belediye başkanı seçilen eczacıların, eczanelerini mesul müdür marifetiyle idare edebileceği (m.8,9.10,17); hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden ayrılan bir eczacının bu ayrılış süresi yirmi dört saati aştığı taktirde mahallin en büyük sağlık amirine yazı ile haber vereceği(m:35), ambalajsız veya ambalajı açılmış olarak bozuk veya zamanı geçmiş veya mağşuş veya gayrisaf ilaç ile ambalajı olsa bile zamanı geçmiş ilaç bulunduran kişiye, fiili Türk Ceza hükümlerine göre ceza sorumluluğunu gerektirmediği taktirde beşyüz Türk Lirası para cezası verileceği (m:41) ön görülmüştür.

4.2.2. Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğünde, eczacının, hekim veya herhangi bir şahsı aracı olarak kullanamayacağı, hastanın dilediği eczaneyi serbestçe seçmesine engel olamayacağı gösterilmiştir (27.7.68 tarihli ve 12961 nolu R.G. yayınlanan Tüzüğün 8. maddesi).

4.2.3. Eczane ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (13.10.1992 tarihli ve 21374 s.R.G.).

4.2.4. Türk Ceza Yasasının 157'nci maddesinde " Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir" hükmüyle dolandırıcılık tanımlanmış, 158/e bendinde de söz konusu dolandırıcılığın " Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak " yapılması cezayı arttıran bir durum olarak gösterilmiştir (Nitelikli dolandırıcılık).

4.2.4.1. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK, Resmi belgede sahtecilik,m: 204**)**.

4.2.4.2. "Resmi Belge Hükmündeki Belgeler" başlıklı 210'uncu maddenin ikinci fıkrasında "Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur"(TCK, madde:210/2).

4.2.4.3 "Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur".(TCK, madde:212).

(*) İlaç İşlemleri ile ilgili mevzuatta özellikle Sağlık Uygulama Tebliğinde veya genelgelerde sık yapılan değişiklikler nedeniyle, güncel bilgiler takip edilmelidir.

5. Eczanelerle İlgili Genel Bilgiler

5.1. Protokol eki Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metnini ve diğer belgeleri (kimlik, ruhsat imza sirküsü,…) taşra teşkilatına veren eczacı ile sözleşme yapılmakta ve kendisine provizyon şifresi verilerek reçete kabulü sağlanmaktadır (protokol, m:7.7/7.8). Ayrıca 18 numarası, il trafik numarası ve dört numaralı sıra sayısını gösteren bir eczane sicil numarası verilerek dosya açılmaktadır. (Kurumumuzda, tüm eczane sicillerinin ilk 2 numarası 18, takip eden iki numara faaliyette bulunulan ilin trafik numarası ve son dört rakam eczane il sıra numarasıdır. Örneğin Ankara da faaliyet gösteren 1 sıra numaralı Eczane için verilen sicil numarası 18060001 dir.).

5.2. 16 İl Müdürlüğündeki 23 Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinde yürütülmekte olan sağlık ödeme işlemleri, 01.03.2009 tarihinden itibaren 15 İlde kurulan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde de yapılacaktır. Söz konusu sağlık sosyal güvenlik merkezinin bulunduğu iller ve bunların görevleri kapsamındaki illeri gösteren listeler 26.11.2008 tarihli ve 2008/101 sayılı genelge ekinde yayınlanmıştır.

5.3. Kurum bilgisayar kayıtlarında her eczaneye yapılan tüm reçete ödemeleri, hak sahipleri için ödenen tüm ilaç bilgileri, bu reçetelerin yazıldığı sağlık kurumları, reçeteyi düzenleyen doktorlar… yer almaktadır. Bu bilgiler Kurumsal Bilgi Portalında, Medula sisteminde ve Veri Ambarında kayıtlıdır. Medula Sisteminde, yatarak tedavi gören hastaların sağlık tesisinin kendi eczanesinden hastanın tedavisi için kullanılan ilaçlar yer almaktadır. Bunun için Başkanlığımız aracılığıyla Teknoloji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığından şifre alınmalı yahut görev konusu ile ilgili gerekli bilgiler adı geçen Başkanlıktan yazı ile istenmelidir. 2007 yılından önceki döneme ait bilgiler Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığından alınmalıdır.

6. Görev Onayının Değerlendirilmesi

6.1. Eczane ile ilgili görev onaylarına ilişkin yazılar (ihbar, şikayet dilekçesi dahil) genelde dört kanaldan gelmektedir: 1- Diğer resmi kurumlar veya Müfettişlerimizden gelen inceleme/soruşturma talepleri, 2- Ödeme birimlerinin talepleri 3-İhbar ve şikayetler 4-Cumhuriyet Savcılıkları.

6.2. Görevlendirme onayları hemen okunmalı ve konu öğrenilmelidir. Özellikle Cumhuriyet Savcılıklarından gelen taleplerin öncelikle yerine getirilmesi sağlanmalıdır.

6.3. Görev onayında suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli ipuçlarının varlığı halinde hiç vakit kaybetmeden gerekli tedbirler (örneğin C. Başsavcılıkları aracılığıyla arama yaptırılması veya Protokolde belirtilen ve sonraki bölümde gösterilen idari incelemenin yapılması/yaptırılması dahil) alınmalıdır.

6.4. Görev onayı çerçevesinde reçete veya sağlık raporu konusu ilaçlar etüd edilmeli, kullanım özellikleri öğrenilmelidir. Bu husus, ifade alınması sırasında, reçete sahibinin ilaçları (örneğin enjeksiyon yapılıp yapılmadığını) hatırlaması yönünden yararlı olabilecektir.

6.5. Kurumumuz bilgisayar portalı, medula sistemi ve veri ambarı ile ilgili şifreler Başkanlığımız aracılığıyla Teknoloji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığından temin edilerek, ilgili eczaneye ait bilgisayar bilgilerine ulaşılmalı veya aynı mahiyetteki bilgiler anılan Başkanlıktan yazılı olarak istenmeli ve elde edilen bilgiler inceleme onayı doğrultusunda değerlendirilmelidir.

6.6. Bu değerlendirmede Eczane ödemelerindeki ani yükselme tarih(ler)i, çok sık reçete edilen ilaçlar, adına çok sık reçete yazılmış hak sahipleri, çok sık reçete düzenleyen doktorlar dikkate alınarak ilgili ödeme müdürlüğünden reçete veya ödeme evrakları, gerekli görülürse sözleşme dosyası istenmelidir. Olayın kapsamı başlangıçta bilinemeyeceğinden, ödeme müdürlüklerinin işlem yoğunluğu dikkate alınarak onay tarihi veya şikayet tarihinden en az 6 ay (sahte kupürlerde en az bir yıl) önceki döneme ait iddialara ilişkin reçetelerin istenmesi, elde edilen bulgular çerçevesinde gerektiğinde daha önceki dönemlere ait reçetelerin incelemeye alınması sağlanmalıdır.

7. Eczane Nezdinde İnceleme Yapılması

7.1. Eczane denetimlerinin, eczane mahallinde yapılması esastır. Ancak görev onaylarının gerekli ön hazırlık yapılmadan

gelmesi ve iddiaların soyut olması halinde, reçete sahiplerinin mektupla veya istinabe yoluyla bilgilerine başvurulabilir. Bunun sonucuna göre, gerekiyorsa, inceleme eczane mahallinde tamamlanmalıdır.

7.2. 2009 yılı Eczane Protokolünde Müfettişlerin veya Kurum yetkililerinin Protokol uygulaması ile ilgili hususları **eczane nezdinde inceleme** yetkisinin olduğu taraflarca kabul edilmiştir (Protokol,6.16). Eczane denetim süreci içinde bu yetki gerekli görmesi halinde Müfettiş tarafından kullanılabilir.

7.3. Eczanede yapılacak denetim öncesinde Bölge Ecza Odasından yazı ile denetçi eczacı istenmesi gereklidir. Denetimin sağlıklı yapılabilmesi için hangi ilçeye veya eczaneye gidileceği saklı tutulmalıdır. Bölge Eczacı Odalarının listesi ekte gösterilmiştir(Ek:3).

7.4. Bölge Eczacı Odasının denetçi eczacı görevlendirmesi veya görevlendirmemesi halinde dahi, Kurum eczacısı ve ödeme işlemlerinde yetkili bir personel mutlaka eczane denetiminde bulunmalı ve tutanaklarda gösterilmelidir.

7.5. Eczane denetiminde eczane çalışanlarının sigortalıkları da denetlenmeli ve buna ilişkin gerekli tutanaklar tutulmalıdır.

7.6. Eczane denetimlerinde; eczacı, eczane çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler hariç, sağlık karnesi ve/veya sağlık raporu (aslı veya fotokopisi) bulunduğunun tespit edilmesi halinde durum tutanakta belirtilir.

7.7. Sağlık karnesi ve/veya sağlık raporu bulundurulması halinde cezai şart uygulanması ve Eczanenin yazılı uyarılması, tespit edilen karne veya sağlık raporu sayısının onun üzerinde olması halinde sözleşmenin 3 ay süreyle feshedilmesi Müfettiş raporunda belirtilir (Protokol, m: 6.3.2).

7.8. Eczane denetiminde kupür, kupürü kesilmiş ilaç bulunması halinde, bunlara el konulur, tutanak tutulur, gerekli değerlendirme ve inceleme yapıldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.

7.9. Protokol hükümlerine göre Eczane nezdinde yapılan denetimlerde, incelemenin Eczacının izni ile yapıldığı, eczacının herhangi bir zararı veya kaybının olmadığı tutanakta belirtilmelidir. Eczacının protokole göre denetim yapılmasını kabul etmemesi halinde durum tutanakta belirtilmekle yetinilir.

7.10. İnceleme/soruşturma onayı çerçevesinde ilgili ilaçların giriş ve çıkışları kanuni defterlerle kontrol edilebilir veya mali müşavirce onaylı malzeme giriş ve çıkışları düzenlettirilebilir.

8. Sağlık Kurumlarında İnceleme Yapılması

8.1. Onay kapsamındaki reçete veya raporların sıhhati konusunda tereddütlerin varlığı halinde, söz konusu belgelerin düzenlendiği sağlık kurumlarında gerekli inceleme yapılır veya kayıtların tetkiki veya teyidi yaptırılır. Reçetelerin protokol defterinde kayıtlı olup olmadığı veya hasta dosyasından protokol kaydı alıp almadığı tutanağa bağlanır veya sağlık kurum/kuruluşundan yazı ile sorulur.

8.2. Yatan hastalara ait dosyalarla, reçete bilgilerinin uygunluğu incelenir.

8.3. Reçete veya raporların sıhhatinde tereddütler varsa, ilgili reçete veya rapor doktora gösterilerek kendisine ait olup olmadığı konusunda tespit yapılmalıdır.

9. Bilirkişi Uygulaması

9.1. Belli bir kişiye çok sık ve fazla miktarda ilaç yazılması yahut reçetede belirtilen tanının reçete sahibinde olmadığının öğrenilmesi halinde, hak sahibinin muayene edilmesi dahil, reçetelerin tıbbi uygunluk yönünden incelenmesi Kurum doktorlarından ya da diğer sağlık kurumlarından istenebilir.

9.2. Reçete ve sağlık raporu sahteliğinin veya tahrifatının söz konusu olduğu hallerde, suçlunun belirlenmesini teminin kriminal inceleme yaptırılabilir. Bu maksatla sahte reçete yazdığı veya imzaladığı düşünülen şahısların yazı ve imza örnekleri temin edilmelidir.

9.3. Sahte kupürün söz konusu olması halinde üretici veya ithalatçı firmalardan kupür incelemesi yaptırılabilir. Bu incelemede kupürün hangi yönlerden firmaya ait olmadığının açıklanması istenmelidir.

9.4. Bilirkişi uygulamasında konunun hızlı çözümünü sağlamak için, incelenmesi istenen reçete veya raporların veya yazı örneklerinin abartılı olmamasına özen gösterilmelidir.

10. İfade Alınması

10.1. Eczane çalışmalarının önemli bir ayağı reçete sahiplerinin bilgisine başvurulmasıdır. Ancak özellikle yaşlı ya da sağlık durumları iyi olmayan kişilerin ifadelerinin yanıltıcı olabileceği göz önüne alınmalıdır.

10.2. Reçete sahipleri posta kanalıyla veya gerekli görülmesi halinde Tebligat Kanununa uygun olarak davet edilebilir. Keza, özellikle reçete arkasındaki telefonlardan yararlanarak sözlü olarak da çağrı yapılabilir.

10.3. Genelde reçete sahipleri bilgi toplamak amacıyla çağrıldığından çeşitli nedenlerle bu davete uymayan olabilmektedir. Bu nedenle daha çok reçete sahibinin çağrılmasında fayda olabilir. Reçete sahibinin mutlaka çağrılması gereken bir hususun varlığı halinde, kolluk kuvvetlerinden yararlanılabilir.

10.4. Reçete sahiplerinin ifade veremeyecek bir durumu varsa (sağlık nedenleri, başka bir şehirde olması, çocuk olması…), konudan bilgi sahibi olan yakınının ifadesine başvurulabilir veya yazı ile beyanı alınabilir.

10.5. Davetiye yazılarında veya sözlü taleplerde, reçete sahibinin (varsa) karnesini ve kullandığı ilaçların kutularını getirmesi istenmelidir. Reçete sahiplerinin belli bir yaşın üzerinde ve bazı rahatsızlıkları olduğu göz önüne alınarak onları tedirgin etmeyecek bir üslupla davetiye yazısı hazırlanmalıdır.

10.6. İfade alınması sırasında diğer reçete sahiplerinin bulunmaması, birbirlerinden etkilenmemeleri sağlanmalıdır.

10.7. İfade almadan önce sorular belirlenmeli ve reçete sahibine veya yakınına sorulmalıdır. İfade sırasında inceleme konusu ilaç kutularının bulundurulması faydalı olabilir. İfade sahibinde bulunulan rahatsızlıklar ve kullandığı ilaçlar tutanağa geçirilmeli ve reçetenin düzenlendiği sağlık kuruluşuna gidip gitmediği, ilgili doktora muayene olup olmadığı, ilaçları Eczaneden alıp almadığı ve kullanıp kullanmadığı mutlaka sorulmalıdır.

10.8. Reçete arkasındaki alındı imzası hukuki bakımdan önemlidir. Çünkü söz konusu imza, reçetede yazılı ilaçların alındığını veya Eczacının reçetedeki ilaçları verdiğini göstermektedir. Bu nedenle şayet varsa ifade ile imza arasındaki çelişki mutlaka açıklattırılmalı, gerekli görülmesi halinde imza örneği alınarak kriminal bir inceleme yaptırılmalıdır.

10.9. Bir hak sahibinin alındı imzası kendisine ait olmasına rağmen, bazı ilaçları almadığını söylemesi açıklığa kavuşturulmalı, reçete işlemleri sırasında imzanın açığa mı yoksa "… kalem ilaç …. Kutu ilacı aldım" ibaresi basılı iken mi atıldığı öğrenilmeye çalışılmalıdır.

10.10. Reçete sahibince ilaçların alınmadığı belirtilmesine rağmen, reçete arkasında birinci derece yakını veya bunun dışındaki kişilerin alındı imzası ve ad-soyadı, adres, T.C kimlik numarası veya başka bir belge numarası bulunan kişilerin de ifadesine başvurulması ve ilaçlara ne yapıldığının bilinmesi gerekmektedir.

10.11. Reçete sahiplerince alınmadığı bildirilen reçeteler, ilgili sağlık kurumu kayıtlarından araştırılmalı ve ilgili doktora gösterilerek reçetenin kendisi tarafından imzalanıp imzalanmadığı öğrenilmeli ve gerekiyorsa ifadesine başvurulmalıdır.

10.12. Reçete, rapor veya bunlara ilişkin belgelerde ortaya çıkan tüm hususlar Eczacı ifadesinde sorgulanmalıdır. Bu sorgulama sırasında hak sahipleri veya reçete sahipleri ile Eczacı veya eczane çalışanları yüzleştirilmemelidir. Gerekli görülmesi halinde Eczacı çalışanlarının da ifadesi alınabilir.

11. Yatan Hastalara Ait Reçeteler

11.1. Yatarak tedavilerde hastanede kullanılacak ilaçların hastane tarafından temini zorunludur (SUT,12.1.2/1). Ancak sözleşmeli **resmi kurumların** temin edemediği ilaçları dışarıdan aldırması mümkündür. Bu durumda (eczanemizde yoktur, yatan hasta) kaşeli, başhekimlik onaylı reçeteler anlaşmalı eczanelerden karşılandığında, yatan hastanın ifadesinin alınmasına ihtiyaç olmayabilir. Çünkü yatan hastaların hangi ilaç tedavisini gördüğü hasta ifadesinden çok, hasta dosyasındaki belgelerden (hasta tabelası, hemşire gözlem kağıdı, epikriz raporu) öğrenilir. Bu nedenle hastaya kullanılmayan veya hastanın tedavisi ile ilgili olmayan ilaçların reçete

edilmesi halinde, durum hastane yönetiminin atayacağı bir doktor ile birlikte tespit edilir. Gerek görülürse ilgili hasta belgelerinin tasdikli fotokopileri alınır.

11.2. Söz konusu tespit ile ilgili olarak, şayet Eczacı tarafından protokolde belirtildiği şekilde gerekli formaliteler yerine getirilerek ilaç verilmişse (ilaçları kimin aldığının reçete arkasında belirtilmesi, imzası, adresi, telefon numarası veya T.C.Kimlik numarasının alınması), Eczanenin olaya bir katılımı tespit edilememişse, sorumluluğun reçeteyi imzalayan doktora ve O'nu çalıştıran sağlık kuruluşuna ait olduğu açıktır. İlgili doktorun, reçetenin kendisi tarafından düzenlenip düzenlenmediği, imzanın kendisine ait olup olmadığı ve reçete veya raporu yazma nedeni ifadesinde açıklattırılmalıdır. Bazı kamu personelinin ayrı bir soruşturma usulüne tabi olduğunu belirterek ifade vermekten kaçınması mümkündür. İfadenin savunma amaçlı değil, bilgi amaçlı olduğu hatırlatılmalı, gerektiğinde ilgili Başhekimlik aracılığıyla yazılı ifade aldırılmalıdır.

11.3. Eczanenin **şeklen** üzerine düşen tüm hususları yerine getirmesine rağmen, reçetenin sahte olduğunu bilebilecek veya ilaçların hasta tedavisi ile ilgisinin olmadığını anlayabilecek durumda olduğunun anlaşılması halinde, eczacının da suça iştiraki olduğu açıktır. Bu durum, uygulamada, reçete toplattıran veya reçete karşılığında, hastane personeline belli bir yüzde veya para ödeyen eczaneler için söz konusu olabilecektir.

11.4. Sözleşmeli eczanelerden karşılanan ilaçlarla, sağlık kuruluşlarınca karşılanan ve Medula sisteminde kayıtlı ilaçların, gerektiğinde, hasta dosyaları ile birlikte değerlendirilmesi ve Kurum kaybının olup olmadığının öğrenilmesi sağlanmalıdır.

12. Sahte Reçeteler

12.1. Bir doktorun isim ve imzasının taklit edilerek reçete düzenlenmesi söz konusu olduğunda, aynı nitelikteki (doktor ismi, diploma numarası, çalıştığı kurum) tüm reçetelere ait bilgiler bilgisayar veri ambarından alınarak, ödeme müdürlüklerinden reçeteler temin edilir. İlgili doktora gösterilerek reçetelerin kendisi tarafından düzenlenmediği ve imzalanmadığı hususu tutanağa bağlanmalıdır. Gerek görüldüğünde, doktorun yazı örnekleri ve imzası da ayrı bir tutanakta gösterilmelidir.

12.2. Sahte reçetelerin kurum/kuruluş kayıtlarında(protokol defterlerinde) olup olmadığı incelenmeli ve tutanağa bağlanmalıdır. Sahte reçetelerin protokol defterlerinde kayıtlı olması halinde, sağlık kurumu çalışanlarından birisinin fail veya failin ortağı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

12.3. Sahte reçetelerde ismi yazılı sigortalı veya emeklilerin bilgisine başvurulması ve olayın aydınlatılması sağlanmalıdır. Sahte reçete olduğu kayıtlardan ve doktor ifadesinden anlaşılmasına rağmen, reçete sahiplerinin ilgili doktora muayene olduğuna ilişkin beyanları üzerinde durulmalı ve bunların sahte reçete tanziminde katılımının olabileceği dikkate alınmalıdır.

12.4. Sahte reçetelerden eczacının sorumlu tutulabilmesi için, eczacı kastının ortaya konması gereklidir (2009 protokolü, 6.3.19). Bu nedenle sahte reçete olayında eczane bağlantısının kurulması, eczacının, ilaç verme formalitelerine uyup uymadığının sorgulanması, reçetenin sahteliğini bilecek durumda olup olmadığının belirlenmesi gereklidir.

12.5. Reçete sahteciliğinin başka bir şekli, fikri sahteciliktir. Şeklen doğru bir reçetedeki ilaç bilgilerinin hak sahibi veya O'nun tedavisi ile ilgili olmaması halidir. Dolayısıyla bu tür sahtecilikte de eczacı doktor işbirliğinin ortaya konması gereklidir. Böyle bir

işbirliği söz konusu değilse, örneğin eczacı ilaç verirken ilaç alanın ad ve soyadı, telefon numarası, adresi, imzası, T.C.kimlik numarası veya ibraz edilen diğer kimlik numarasını almışsa, ilaçları alan şahısla birlikte reçeteyi düzenleyen doktorun ve O'nu çalıştıran sağlık kuruluşunun hukuki ve mali sorumluluğu bulunmaktadır.

13. Sahte Raporlar

13.1. İlgili tek uzman hekim tarafından düzenlenen Uzman Hekim Raporu veya ilgili daldan üç uzman hekim katılımıyla veya ilgili dal uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından seçilen uzman hekimlerin katılımı ile en az üç uzman hekimden oluşan Sağlık Kurulu Raporu ile üç aylık tedavi dozu ve 4 kalem ilaç sınırlaması dikkate alınmadan Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar yazılabilmektedir (SUT;12.1.3/12.3/21). Bu nedenle son yıllarda reçete sahiplerinin haberi dahi olmadan sahte raporlar düzenlenmiştir.

13.2. Sahte Raporlar, sahte reçete bölümünde belirtildiği üzere şeklen (uzman doktorun veya doktorların isim ve imzası taklit edilerek) veya fikri sahtecilik şeklinde (hasta ile ilgisi olmayan tanılar yazılarak) gerçekleşebilmektedir. Eczacının sorumluluğu, sahta reçete de olduğu gibi, eczacının kastına bağlı tutulmuştur (2009 Protokolü, s:6.3.19). Bu nedenle, sahte reçete ile ilgili tüm işlemler sahte rapor için de geçerlidir.

14. Sahte Kupürler

14.1. Sahte kupür ile ilgili iddialara ilişkin delillerin çok kuvvetli olması halinde C.Başsavcılıklarından eczacı veya şüpheli şahısların ev ve işyerlerinin aranması talep edilebilir.

14.2. Sahte kupürle ilgili çalışmalarda başlangıçta 1 yıl geriye gidilerek aynı mahiyetteki eczane ödemeleri ödeme müdürlüklerinden istenmeli, incelemeden çıkan sonuca göre

gerektiğinde daha geriye gidilerek aynı mahiyetteki reçeteler de inceleme kapsamına alınmalıdır.

14.3. Sahte kupürlerle ilgili tespitler için ilgili ilaç firmalarına gönderilecek kupürler kesinlikle reçeteden ayrılmamalıdır. Reçetelerin birer fotokopisi saklanmalıdır.

14.4. Sahte reçete ve sahte raporda olduğu gibi, sahte kupür nedeniyle eczacının sorumlu tutulabilmesi için kast şartı aranmaktadır (2009 protokolü, 6.3.19). Bu nedenle sahte kupürle ilgili reçetelerin sahte olması, bu reçetelerin eczacı tarafından veya bilgisi dahilinde yazıldığının anlaşılması, ilgili ilaçların alınmadığına ilişkin reçete sahiplerinin beyanları, eczacının ilaç girişlerini gösterememesi, reçete formalitelerini yerine getirmemiş olması (imzaların reçete sahibine veya yakınına ait olmaması, kimin aldığını yazmaması…) kastın varlığı olarak düşünülmelidir.

14.5. Sahte kupür incelemelerinde karşılaşılan sorunlardan birisi, sahte kupürlü reçetenin sahih olması, ilaçların reçete sahiplerince alınmış olması veya bu tedavinin hasta için gerekli olmasıdır. Eczacının ilgili depolardan alım faturalarını da ibraz ettiği bu durumda, sahte kupür ile eczacı kastının kurulması mümkün olmamasına rağmen, konunun ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına (faili meçhul suç olarak) ihbar edilmesi gereklidir.

15. Tahrifatlı Reçeteler

Reçete veya reçete ekinde bulunması gereken belgelerde tahrifat olması halinde bunların Eczane tarafından işleme konmaması gerekir. Ancak, özellikle eczacı veya çalışanlarınca Kurum zararını hedefleyen tahrifatlı reçete veya ekleriyle sisteme girilmesi halinde, doktor, hasta ifadesi, gerektiğinde kriminal bir incelemeyle tahrifat delillendirilmelidir.

16. Yönlendirme Konuları

16.1. Deontoloji Tüzüğünde eczacının hekim veya herhangi bir şahsı aracı olarak kullanamayacağı, hastanın dilediği eczaneyi serbestçe seçmesine engel olamayacağı belirtilmiştir (Tüzük, m:8).

16.2. Eczaneler kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla, kurye şirketleri ile açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar, kurye elamanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme yapamaz. Internet, faks, telefon, kurye, komisyoncu, ve benzeri yollarla gelen reçeteler kabul edilmez. Eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz *(Bölge Eczacı Odası koordinasyonluğunda yapılan reçete dağıtım işlemleri bu kapsamın dışındadır,* Protokol, m:6.3.24).

16.3. Uygulamada bazı eczanelerin belli doktorlarla işbirliği içinde reçete yazdırdığı veya sağlık kuruluşunun ve reçete sahiplerinin uzağında olmasına rağmen reçete toplattığı görülmektedir. Gerek bilgisayar sistemimizdeki bilgilerin değerlendirilmesinden, gerek reçete sahiplerinin ifadelerinden, gerekse sağlık kuruluşu çalışanlarının beyanlarından yönlendirme olup olmadığı belirlenmeli ve tespiti halinde 1 yıl fesih süresi uygulanmalıdır.

17. Raporlama İşlemleri

17.1. Elde edilen tüm maddi belgelerin değerlendirilmesi sonucu eczacı veya diğer kişiler hakkında herhangi bir tedbir önerilmiyorsa, inceleme raporu yazılır. Bu raporda, ifadelerde ve çeşitli belgelerde bahsedilen reçeteler ek yapılmayabilir.

17.2. Eczacı veya diğer kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu yönünden bir tedbir önerilmemekle birlikte, protokol gereği cezai şart uygulaması ve eczane feshi söz konusuysa, tüm reçete ekleri dahil soruşturma raporu yazılır. Raporda, cezai şart ve fesih işlemi

uygulanması önerilen eczacının kimlik bilgilerinin, eczanenin ismi ve adres bilgilerinin Maliye Bakanlığı ile Valililiğe (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne), Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine bildirilmesi belirtilir (Protokol, m:6.10).

17.3. Konusu suç teşkil eden eylemlerin varlığı halinde özel soruşturma usullerine tabi olanlar hariç diğer kişiler hakkında evrakta sahtekarlık veya nitelikli dolandırıcılık veya her iki suç yönüyle Soruşturma Raporu düzenlenir. Soruşturma Raporunda suçla ilgili tüm reçete ve evraklar ek yapılır. Suçla ilgisi bulunmayan ifade ve reçeteler rapora konmaz.

17.4. Soruşturma raporunda protokolde belirtilen cezai şart hesaplanır ve fesih sebebinin Protokolün hangi maddesi gereği yapıldığı belirtilir. Kurum zararı hesaplanır ve kimin sorumlu olduğu gösterilir. Kanuni faizin İdare tarafından ayrıca hesaplanacağı belirtilir.

17.5. Özel soruşturma usullerine tabi personelden 4483 sayılı yasaya tabi olanlar için il valiliğine veya ilçe kaymakamlığına, 2547 sayılı yasaya tabi personel için de ilgili Üniversite Rektörlüğüne Soruşturma raporunun bir nüshası gönderilerek, ilgili personel hakkında Türk Ceza Kanunu ve personel kanunlarındaki disiplin ile ilgili hükümlerin uygulanması istenmelidir.

17.6. Eczacı veya suç ile ilgili kesin tespitler söz konusuysa ve aynı yöndeki reçetelerin toplanmasının zaman alacağı anlaşılırsa, eldeki bulgularla soruşturma raporu yazılarak ilgili mercilerin harekete geçmesi veya işlem yapması sağlanmalıdır. Arşiv çalışmasına takiben ek soruşturma raporu en kısa sürede tamamlanmalıdır.

EK:1

(01.02.2009'dan geçerli Protokol'ün 5. ve 6´ncı maddeleri)

5.CEZAİ ŞART TAHSİLİ

5.1. Protokolün (6.3) numaralı maddesinde (6.3.19) numaralı maddesi hariç olmak üzere belirtilen fiiller için Kurumca uygulanacak cezai şart tutarının her fiil için 250 TL'den az olması halinde, alınacak cezai şart bedeli 250 TL'ye tamamlanır. Protokolün (6.3) numaralı maddesinde (6.3.19) numaralı maddesi hariç olmak üzere belirtilen aynı fiilin/fiillerin son bir yıl içinde tekrarlandığının tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart bedeli her fiil için 500 TL'den az olması halinde, alınacak cezai şart bedeli 500 TL'ye tamamlanır.

5.2. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde aynı fiilin tekrarının tespiti halinde cezai şart, ilk tespit gibi uygulanır.

5.3. Bir fatura dönemi için uygulanacak cezai şartın hesaplanmasında, aynı veya ayrı her bir tespit edilen fiil/fiiller için öngörülen cezai şart tutarı toplanarak tahsil edilir.

5.4. Kurumca cezai şartların eczacıya tebliğinde, tespit edilen fiil ve cezai şart tutarı açıkça belirtilir.

5.5. Cezai şartın tutarı; eczacının Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Eczacının alacağının cezai şart tutarını karşılamaması veya alacağının olmaması halinde, genel hükümlere göre tahsil edilir.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE CEZAİ ŞARTLAR-

6.1 Taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilir.

6.2. Eczanenin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Eczanenin kapanması halinde bu durum 15 gün içinde Kuruma bildirilecektir. Kapanma tarihine kadar eczane tarafından karşılanan reçeteler ve faturaları, protokolün (4.2) numaralı maddesi doğrultusunda Kuruma teslim edilecektir. Bu faturalar Kurum tarafından öncelikli olarak kontrol edilir ve bedelleri 4.3 Maddesi esaslarına göre ödenir.

6.3. Cezai şart uygulanacak fiiller, fesih nedeni fiiller ve sözleşme yapılmayacak süreler aşağıda belirtilmiştir.

6.3.1. Reçetede yazılan ilacın eczanede bulunduğu halde eczanede bulunan ilacın verilmediğinin ve/veya reçete karşılamada reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sisteminin onay verdiği reçetesinde yer alan ilacı hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde, eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.2. Eczanede yapılan denetimlerde, eczacı, eczane çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler hariç, bu protokol kapsamındaki kişilere ve TEB ile ilaç hizmeti sunumuna yönelik olarak protokol imzalamış diğer kurum mensuplarına ait sağlık karneleri ve/veya sağlık raporu (aslı veya fotokopisi) bulundurulduğunun tespiti halinde 250 TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde 250 TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak eczanede bulunan karne veya sağlık raporu sayısının (aslı veya fotokopisi) 10 (on) un üzerinde olması halinde uyarı yapılmaksızın sözleşme feshedilir ve 3 ay süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.3. Eczanenin Kuruma fatura ettiği reçetelerde bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine yada yakınına teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçete sahibine veya ilaçların

teslim edildiği yakınına ait olmadığının tespit edilmesi halinde, reçete bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.4. Reçetelere orijinal ambalajından kesilmiş ilaç fiyat kupürleri ve barkodu yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taşıyan kısımlarının reçetede kupür yerine kullanılarak Kuruma fatura edilmesi durumunun ilk tespitinde kupür tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde kupür tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.5. Sözleşmesi feshedilen eczaneye ait reçetelerin Kurum ile sözleşmeli eczane tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde, reçete bedelinin 5 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.6. Hekim numunesi olan ilaçlara ait fiyat kupürlerinin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde kupür tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde kupür tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1(bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.7. Eczanede yapılan incelemeler sonucunda reçete karşılığı bulunmayan ve kime ait olduğu ispatlanamayan ve bedeli en fazla 500 TL olan, ilaç kupürlerinin veya kupürü kesilmiş ilaçların bulunması durumunda, yazılı uyarı yapılır. Belirtilen bedelin üstünde kupür veya kupürü kesilmiş ilaç tespit edilmesi halinde kupür bedelinin/ kupürü kesilmiş ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 ay süreyle sözleşme yapılmaz.

Bu fiilin/fiillerin tekrarı halinde kupür bedelinin/kupürü kesilmiş ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanır ve sözleşme feshedilerek 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.8. Eczane provizyon sistemine reçete girişinde; reçetede kayıtlı ilaç/ilaçlar yerine pahalı ilaç barkodunun okutularak ucuz olanının verilmesi, (SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Eşdeğer Ürün Grubu sütununda yer almayan ilaçlar için) ve pahalı ilaç üzerinden fatura düzenlenmesinin tespiti halinde fatura edilen bu ilaç/ilaçlara ait bedelin 5 katı tutarı cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde fatura edilen bu ilaç/ilaçlara ait bedelin 5 katı tutarı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.9. Reçetede yazılı ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi durumunda, yanlış verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.10. Hasta veya hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlara ait fiyat kupürlerinin yer aldığı reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde kupür bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Tekrarı halinde ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz (Kurum tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere eczanede bekletildiği saptanan ilaçlar hariçtir).

6.3.11. Bozuk veya gayri saf ilaç verilmesi halinde verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczanenin sözleşmesi feshedilir 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz.

Son kullanım tarihi geçmiş ilaç verilmesi halinde verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı

olarak uyarılır. Tekrarı halinde verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.12. Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya poliklinik muayene katılım payı tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte tahsil edilmeyen katılım paylarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. (Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurum tarafından madde hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı tarafından, poliklinik muayene katılım payı tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart tutarının hesaplanmasında (5.1) numaralı madde hükmü uygulanmaz. Provizyon sisteminde, eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarının eczane tarafından tahsil edilmediğinin tespiti halinde, bu madde hükmü uygulanır.

6.3.13. Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait ilaçların kupürlerinin veya bedeli daha önce ödenmiş reçetelere ait kupürlerin Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde kupür tutarlarının 5 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz (Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait ilaçların dağıtım kanallarından sehven eczanelere satıldığı haller hariç).

6.3.14. Hekim tarafından reçeteye eklenerek hastaya verilen ilaçlar hariç olmak üzere, reçeteye sonradan ilaç eklenerek Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.15. Kuruma fatura edilen reçetede yada reçete ekinde bulunması gereken belgelerde (tıbbi bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere) eczacı veya eczane çalışanları tarafından tahrifat yapıldığının tespiti halinde reçete bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.16. Eczanede bulunduğu tespit edilen sağlık karnelerinin kullanılarak Kurumun zarara uğratıldığının tespiti halinde Kurumun uğradığı zararın 10 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.17. Herhangi bir kartona, kağıda veya benzeri bir zemine sürşarj etiketi yapıştırılarak reçeteye eklenmesi, sürşarj yoluyla mükerrer satış yapmak için ilaç fiyat kupürünün pencere şeklinde kesilerek veya fiyat kupürünün soyularak reçeteye eklenmesi durumunun tespiti halinde bu kupürlerin 5 katı tutarı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.

6.3.18. Kurumca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı, hayali reçete kaydının yapılması durumunun tespiti halinde reçete bedelinin 5 katı tutarı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumca kabul edilmesi halinde bu hüküm uygulanmaz.

6.3.19. Eczacı yada eczane çalışanlarınca Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak Kuruma sahte ilaç fiyat kupürü veya sahte reçete veya sahte rapor fatura edildiğinin tespiti halinde

reçete bedelinin 10 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Uygulanacak cezai şart 10.000 TL'den az olamaz.

Ancak, söz konusu sahte kupür veya sahte reçete veya sahte raporun eczacının kastı dışında üçüncü kişilerin dahli ile Kuruma fatura etme işlemi gerçekleştirilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz.

6.3.20. Eczacı, Kurum ile Kuruma bağlı vakıf, dernek gibi kuruluşlara bağış yapamaz, hediye vb. şekilde katkıda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir, bir yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurumca fesih yapılır. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir.

6.3.21. Muvazaalı olarak eczane işlettiği tespit edilen eczacı ile sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmış ise feshedilir ve bir daha sözleşme yapılmaz.

6.3.22. Eczacı tarafından, eczanenin unvanının ve/veya mesul müdürünün değişmesi halinde unvanın değiştiği ve/veya mesul müdürün ayrıldığı gün yazılı olarak Kuruma bildirilir ve Kurum tarafından bu tarih itibariyle reçete girişi durdurulur mesul müdürün sözleşme yapmaya engel halinin olmaması halinde sözleşme devam eder ve reçete girişi açılır, aksi halde sözleşme feshedilir.

6.3.23. Eczanenin unvanının veya sahip ve mesul müdürünün değişmemesi şartıyla aynı il sınırları içindeki nakil veya adres

değişikliğinin, ruhsat fotokopisinin de eklenerek dilekçe ile değişikliğin gerçekleştiği günden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde Kuruma bildirilmesi halinde yeni bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Bu şekildeki nakil veya adres değişikliğinin süresinde bildirilmemesi halinde gecikilen her gün için eczacı tarafından 100 TL ödenir. Ödenecek cezai şart 1000 TLyi geçemez.

6.3.24. Eczaneler, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla kurye şirketleri ile açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme yapamaz. İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurumca fesih yapılır. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir.

Protokolün 3.7 Maddesi uyarınca Bölge Eczacı Odası koordinasyonluğunda yapılan reçete dağıtım işlemleri bu madde kapsamının dışındadır.

6.4. Bu protokol hükümleri ile ilgili olarak ceza hukuku açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6.5. Hakkında suç duyurusunda bulunulan ve sözleşmesi feshedilen eczacı veya mesul müdür hakkında, takipsizlik kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde sözleşme yapılır.

6.6. Bu protokol hükümleri ile ilgili olarak hakkında suç duyurusunda bulunulan ve açılan Kamu davası sonucunda ceza mahkemesi tarafından beraat kararı verilen eczacının beraat kararından sonra talebi halinde sözleşme yapılır.

6.7. Fiilin/fiillerin tekrar olup olmadığının tespitinde, tebligat tarihleri esas alınır, fiilin/fiillerin işlendiği tarihten geriye doğru Kurumla sözleşmeli olduğu süreler dikkate alınarak son 1 (bir) yıla bakılır.

6.8. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde, uyarı yapılan aynı fiilin/fiillerin tekrarının tespiti halinde, fiilin/fiillerin gerektirdiği fesih hükümleri uygulanmaz, yazılı uyarıyı gerektiren her fiil için eczacı uyarılır.

6.9. Eczacı tarafından, bu protokolün (6.3) numaralı maddesinde belirtilen fiillerden fesih gerektiren birden fazla farklı fiilin aynı fatura döneminde tespiti halinde yeniden sözleşme yapılması için bekleme sürelerinden uzun olan süre uygulanır.

6.10. Protokolün (6.3) numaralı maddesinde belirtilen fiiller nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi halinde, Kurum tarafından, eczacının T.C. kimlik numarası da dahil olmak üzere kimlik bilgileri, eczanenin ismi ve adres bilgileri Maliye Bakanlığı ile Valiliğe (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü), Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine bildirilir. Valilikçe, il düzeyinde (ilçeler dahil) tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Türk Eczacıları Birliğince de bu eczaneler tüm eczacı odalarına bildirilir.

6.11. Fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre içinde sözleşmesi feshedilen eczacının yeni bir isimle veya başka bir adreste (il değişikliği dahil) eczane açması veya eczane devir alması halinde eczacı ile sözleşme yapılmaz.

6.12. Fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre dolduğunda, feshe ilişkin yargı süreci devam etse dahi eczacının talebi halinde sözleşme yapılır.

6.13. Bu protokolün yürürlük tarihinden önceki protokol hükümlerine göre Kuruma fatura edilen ve kontrolleri Kurum tarafından bu protokolün yürürlük tarihinden sonra yapılan reçeteler için, ya da reçete kontrolleri yapılmış olmakla birlikte fesih ile ilgili işlemleri henüz tamamlanmadığı durumlarda tespit edilen fiil/fiiller için, Kurumca bu protokolün (5) ve (6) numaralı maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. Ancak eczacının tespiti yapılan aynı fiil için reçetenin veriliş tarihinde geçerli olan protokol hükümlerinin uygulanması Kurumdan yazılı olarak talep edilirse reçetenin veriliş tarihinde yürürlükte olan protokol hükümleri uygulanır.

6.14. Bu protokolün yürürlük tarihinden önce geçerli olan protokol hükümlerine göre sözleşmesi feshedilen ve Kurum aleyhine feshe ilişkin dava açmış ve ihtiyati tedbir kararı almış eczacı ile ihtiyati tedbir kararı çerçevesinde ihtirazı kayıtla sözleşme devam eder. Ancak ihtiyati tedbir kararının kaldırılması ve/veya davanın reddedilmesi halinde sözleşme feshedilir ve fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre uygulanır. İhtiyati tedbir kararı alınması halinde, bir önceki sözleşmeye şerh konularak sözleşmenin yürürlüğü devam ettirilir.

6.15. Bu protokolün yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle Kurumca veya Kuruma devredilen kurumlarca sözleşmesi feshedilen eczacının yazılı talebi halinde; Kurumca tespit edilen ve sözleşmesinin feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu protokolün (5) ve (6) numaralı maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

Bu protokolün yürürlük tarihinden önce (6.3) numaralı maddede sayılan fiillerden dolayı sözleşmesi feshedilen eczanelerin yazılı talebi üzerine, bu protokoldeki cezai şart ve fesih hükümleri uygulanır. Ancak eczanenin feshine ilişkin fiil için; bu protokol hükümlerinde eczacının yazılı olarak uyarılması ve/veya "tekrarı halinde" yeni bir yaptırım belirtilmiş ise, bu protokolün yürürlük tarihinden önce yapılmış fesih işlemi "yazılı olarak uyarı" ve/veya fesih işlemine esas fiil ise tekrara dayalı yaptırımlar için ilk fiil olarak kabul edilir.

Kurum veya Kuruma devredilen kurumlar aleyhine feshe ilişkin dava açan eczacı;

Devam eden hukuk davası varsa davasından feragat etmek ve feragat nedeniyle mahkeme tarafından reddedilen davaya ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararını Kuruma ibraz etmek şartıyla bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümden yararlanır.

Bu madde hükmü uygulanırken daha önce Kuruma devredilen kurumlar ile yapılan protokoller gereği sözleşmesi feshedilen eczacı için, fesih tarihinden itibaren geçen süre bu protokol hükümlerine göre sözleşme yapılmayacak süreden düşülür.

6.16. Gerek görüldüğü hallerde Kurum, bu protokolün uygulanmasıyla ilgili hususları, eczane nezdinde yapılacak olan da dahil olmak üzere, Kurum Başkanlık Müfettişleri veya Kurum yetkilileri marifeti ile her zaman incelettirebilir. Kurum yetkilileri tarafından yapılacak denetimlerde çalışanların sigortalı olup olmadıklarının tespiti yapılarak, sigortasız çalışanlar Kurumun ilgili birimine bildirilir. Kurum yetkilileri tarafından eczane içinde yapılacak inceleme ve denetimler Bölge Eczacı Odalarınca görevlendirilecek denetçi eczacı ile birlikte yapılır. Bölge Eczacı Odaları, Kurumun denetçi eczacı görevlendirilmesine dair yazılı taleplerini karşılarlar. Bu talebin karşılanmaması halinde denetim Kurum elemanlarınca gerçekleştirilir.

6.17. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından eczanelerde yapılan denetimlerde bu protokolde sözleşmenin feshini ve/veya cezai şart gerektiren hususların tespit edilerek Kuruma bildirilmesi halinde bu durum Kurum tarafından değerlendirilerek yukarıda belirtilen fesih hükümleri ve süreleri ile cezai şartlara ilişkin işlem yapılır.

6.18. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılan denetimlerde, bu protokolde sözleşmenin feshini ve/veya para cezasını gerektiren hususların tespiti halinde bu hususlar Kuruma bildirilir. Kurum tarafından değerlendirilerek yukarıda belirtilen fesih hükümleri ve süreleri ile cezai şarta ilişkin işlem yapılır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

EK-2

Eczacı Odaları	
1. Bölge İstanbul Eczacı Odası	0-212-2176191
2. Bölge Ankara Eczacı Odası	0-312-4250807
3. Bölge İzmir Eczacı Odası	0-232-4833850
4. Bölge Adana Eczacı Odası	0-322-4581050
5. Bölge Konya Eczacı Odası	0-332-3514559
6. Bölge Samsun Eczacı Odası	0-362-4352343
7. Bölge Bursa Eczacı Odası	0-224-2219480
8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası	0-342-3229030
9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası	0-222-2313564
10. Bölge Antalya Eczacı Odası	0-242-2374994
11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası	0-412-2294502
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası	0-352-2226727
13. Bölge Erzurum Eczacı Odası	0-442-3169704
14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası	0-344-2254050
15. Bölge Isparta Eczacı Odası	0-246-2184701
16. Bölge Denizli Eczacı Odası	0-258-2640522
17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası	0-372-2538973
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası	0-462-3213101
19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası	0-282-2613629
20. Bölge Sakarya Eczacı Odası	0-264-2742950
21. Bölge Aydın Eczacı Odası	0-256-2271100
22. Bölge Malatya Eczacı Odası	0-422-3228886
23. Bölge Elazığ Eczacı Odası	0-424-2388372
24. Bölge Ordu Eczacı Odası	0-452-2254654
25. Bölge Mersin Eczacı Odası	0-324-3362030
26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası	0-366-2143452
27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası	0-414-2153037
28. Bölge Hatay Eczacı Odası	0-326-2145647
29. Bölge Manisa Eczacı Odası	0-236-2310090
30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası	0-266-2443305
31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası	0-262-3234932

32. Bölge Muğla Eczacı Odası	0-252-2143332
33. Bölge Afyon Eczacı Odası	0-272-2157328
34. Bölge Aksaray Eczacı Odası	0-382-2137777
35. Bölge Kütahya Eczacı Odası	0-274-2262663
36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası	0-286-2128909
37. Bölge Sivas Eczacı Odası	0-346-2236506
38. Bölge Van Eczacı Odası	0-432-2165676
39. Bölge Edirne Eczacı Odası	0-284-2357690
40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası	0-288-2124033
41. Bölge Tokat Eczacı Odası	0-356-2149896
42. Bölge Giresun Eczacı Odası	0-454-2129545
43. Bölge Mardin Eczacı Odası	0-482-2128747
44. Bölge Batman Eczacı Odası	0-488-2128687
45. Bölge Çorum Eczacı Odası	0-364-2251051
46. Bölge Uşak Eczacı Odası	0-276-2232104
47. Bölge Amasya Eczacı Odası	0-358-2130600
48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası	0-328-8126561
49. Bölge Yozgat Eczacı Odası	0-354-2176444
50. Bölge Karaman Eczacı Odası	0-338-2124625
51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası	0-416-2146272